吉安市人民政府文件

吉府发〔2026〕3号

吉安市人民政府关于印发《吉安市落实长期护理保险制度实施方案》的通知

井冈山管理局，井冈山经开区管委会，各县（市、区）人民政府，庐陵新区管委会，市直各单位：

现将《吉安市落实长期护理保险制度实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2026年6月30日

（此件主动公开）

吉安市落实长期护理保险制度实施方案

为落实长期护理保险制度，推动解决我市失能人员长期护理基本保障需求，根据《江西省建立长期护理保险制度实施方案》，结合实际，制定以下实施方案。

一、目标任务

按照分步实施的原则，2026年底前启动就业人员长期护理保险制度；2028年将未就业人员纳入长期护理保险制度范围，全市全面实施长期护理保险制度。

二、参保筹资

（一）参保对象

用人单位（包括企业、事业单位、机关、社会组织）以及单位职工、退休人员、灵活就业人员和未就业城乡居民等按照属地管理原则，参加长期护理保险。省直有关单位参加本统筹区长期护理保险的，按有关规定执行。

（二）制度模式

长期护理保险基金（以下简称基金）统一建账，资金统筹使用。执行国家规定的长期护理保险基准费率制度，实施动态调整。根据缴费标准不同，待遇标准分为就业人员和未就业人员两类设置。

（三）筹资标准

1.单位职工。单位职工由用人单位和个人共同按月缴纳，费

率为 0.3%；单位职工费率由用人单位和个人按同比例分担，均为 0.15%；缴费基数与职工基本医疗保险一致。用人单位按照规定的费率，在缴纳职工基本医疗保险费时一并向税务部门申报，按时足额缴纳长期护理保险费。职工个人需缴纳的长期护理保险费，由其职工基本医疗保险个人账户代扣代缴或者由用人单位按月代扣代缴。

2.退休人员。退休人员由个人缴费，原用人单位不缴费；退休人员费率为 0.15%，缴费基数为本人基本养老金；经本人同意，个人缴费由其职工基本医疗保险个人账户代扣代缴或者由发放基本养老金的社会保险经办机构代扣代缴。

3.灵活就业人员。灵活就业人员可以按单位职工参保政策参保，也可选择按未就业城乡居民参保政策参保。鼓励灵活就业人员按单位职工参保政策参保。选择按照单位职工参保政策参保的，缴费费率为 0.3%（从基本医疗保险缴费费率中平移 0.15%，从职工基本医疗保险个人账户代扣代缴 0.15%）；按照灵活就业人员参加基本医疗保险的方式缴费，缴费基数为统筹地区上年度社会平均工资的 60%。

4.未就业城乡居民。未就业城乡居民长期护理保险按年度筹集，筹资费率为 0.3%，由个人和政府按 1:1 分担，财政补助由中央财政和地方财政共同承担，具体补助办法按照省级有关规定执行。缴费基数为统筹地区上年度城乡居民人均可支配收入，参照城乡居民基本医疗保险按年缴费。未就业城乡居民长期护理保险

起步当年，费率从0.15%起步平稳过渡到0.3%（第1年费率为0.15%，第2年费率为0.18%，第3年费率为0.22%，第4年费率为0.26%，第5年费率为0.3%）。

5.困难人群。对符合条件的困难人群个人缴费部分予以分类资助，其中：居民医保全额资助人员，长期护理保险个人缴费部分由财政全额资助；居民医保定额资助人员，个人缴费部分由财政按照当年个人缴费标准的50%予以资助。省级及以下财政分担比例参照居民医保资助参保政策。

6.18周岁以下人员。18周岁以下未就业人员跟随父母或其他法定抚养人等参保，不单独筹资。孤儿、事实无人抚养儿童等人员中无法跟从参保的，可视同参保。

（四）筹资渠道

基金主要通过单位、个人、政府、社会等多元渠道筹集。建立长期护理保险制度当年，在充分测算评估后确保调整职工基本医疗保险单位费率后职工基本医疗保险基金累计结余可支付月数不少于12个月，且不出现当期赤字的基础上，从职工基本医疗保险单位缴费费率6.8%中平移0.15%，用作长期护理保险单位缴费费率。

职工基本医疗保险个人账户可用于本人及近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）参加长期护理保险的个人缴费。

三、待遇保障

（一）待遇享受条件。参加基本医疗保险可以正常享受待遇并按时足额缴纳长期护理保险且失能状态长期持续（一般为6个月以上），经申请并通过评估认定的失能人员，可按规定享受相关待遇。长期护理保险制度起步阶段保障重度失能人员。随着经济发展和制度完善，根据国家、省要求逐步扩大保障对象范围，并根据基金支出需求动态调整费率。

（二）待遇保障范围。严格执行国家统一制定的长期护理保险服务项目目录。符合长期护理保险待遇享受条件的人员可选择机构护理、社区护理、居家护理等服务方式。

（三）待遇保障标准。待遇享受不设起付线。根据失能等级、服务提供方式等实行差别化待遇保障政策。符合规定的长期护理服务费用，按照人员参保类别进行支付。基金年度最高支付限额不超过统筹地区上年度城乡居民人均可支配收入的50%，对于相同失能等级的同类参保人年度最高支付限额应保持一致。具体年度限额标准由市医保部门会同有关部门另行制定。

1.就业人员（含单位职工、退休人员）。在机构护理的，基金支付比例为65%；社区护理的，基金支付比例为70%；居家护理的，基金支付比例为75%。

2.未就业人员。在机构护理的，基金支付比例为45%；社区护理的，基金支付比例为50%；居家护理的，基金支付比例为55%。

3.18周岁以下人员。18周岁以下未就业人员符合待遇享受条件的，按照未就业城乡居民的标准享受待遇。

4.灵活就业人员。灵活就业人员依据选择的参保政策类型享受相应待遇。

（四）支付范围。基金主要用于支付符合规定的长期护理服务机构和人员提供长期护理基本服务所发生的费用，原则上不直接向失能人员发放现金。根据国家、省级部署以及我市经济社会发展和基金承受能力，探索将长期护理相关智能化服务、支持性辅助器具等纳入支付范围。

对应由医疗保险支付的医疗费用和机构床位费、膳食费等非护理服务费用以及法律法规规定的其他不予支付的费用，不纳入基金支付范围。领取工伤保险生活护理费的参保人员，不重复享受长期护理保险相关服务待遇。

（五）政策衔接。根据上级有关文件精神，探索建立缴费时长和待遇水平相挂钩的连续参保激励机制，对连续参保的未就业城乡居民按照规定适当提高支付比例。除新生儿等特殊群体外，对未在我市长期护理保险制度启动时初次参保以及中断缴费后再次参保的情形，实施待遇享受等待期、阶段性调低待遇水平等约束性措施。做好长期护理保险与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。支持、引导和鼓励通过慈善捐赠等多种渠道，对特定人群参加长期护理保险个人缴费部分和享受待遇的个人自付费用给予补助。鼓励商业保险公司开发与长期护理保险相衔接的商业长期护理保险，满足参保群众多样化、多层次的护理保障需求。

四、经办服务

（一）失能等级评估

按照全国统一的长期护理保险失能等级评估标准和管理办法，统筹利用现有评估认定资源，鼓励支持发展专业独立的社会化评估机构，实行定点管理。建立评估服务费由基金和个人合理分担机制。参保人首次评估通过的评估服务费，以及按制度要求参加定期复评的评估服务费，由基金支付。建立健全评估人员规范化培训机制。

（二）护理服务管理

长期护理保险护理服务机构实行定点管理，促进长期护理保险定点服务机构资源合理配置，加强长期护理保险定点护理服务机构规范化管理。根据定点管理需要，逐步按照政府采购的有关规定确定定点长期护理服务机构。鼓励支持基层医疗卫生机构、养老服务机构提供长期护理服务，符合条件的按规定纳入定点机构范围。加快推进长期护理服务人员队伍建设，建立健全长期照护师培训培养机制，规范职业技能等级认定工作。

（三）支付管理

建立健全长期护理保险服务质量评价机制和费用控制激励约束机制。建立符合长期护理保险服务特点的支付机制和协商谈判机制，针对不同服务模式，完善按床日、按服务时长等支付方式，明确各种付费方式的适用范围、实施条件等。加强基金结算管理，建立适应长期护理保险特点的总额付费机制。

（四）经办管理

长期护理保险与基本医疗保险同步参保、同步缴费。各级医疗保障经办机构负责实施长期护理保险经办服务，负责编制基金预决算草案。通过公开招标等竞争性方式有序规范引入社会力量参与经办管理服务，相关费用依协议约定从基金中支付。构建长期护理保险评估和服务质控体系。加强对长期护理保险失能等级评估机构、护理服务机构和参与经办的第三方机构的考核评价和激励约束，强化考核结果运用，不得将基金交由经办长期护理保险的第三方机构代管代拨。按照上级部署要求做好跨统筹区的长期护理保险关系转移接续、异地参保、异地享受待遇等相关工作。做好灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保缴费工作，确保按规定享受待遇。加快长期护理保险信息化建设。

五、监督管理

（一）基金管理

基金主要用于长期护理保险待遇支付、失能评估费用支付和参与经办的第三方机构的服务费用等支出。基金纳入社会保障基金财政专户，实行市级统收统支管理，单独建账、单独管理、专款专用。严格执行基金预算管理制度和基金财务制度，科学编制收支预算，做好基金会计核算和统计分析，强化预算绩效管理，加强财会监督和审计监督，建立基金运行监控和风险防范机制。在基金出现支付困难时，按照有关规定及时调整筹资或者待遇政策。

（二）基金监管

加强定点评估机构和服务机构协议管理，规范定点机构服务行为。加强监管能力建设，做好协议管理与行政监管衔接。建立健全基金监管体系，完善监管长效机制。加大基金监管执法力度，创新监管手段和方式，将基金使用纳入飞行检查、日常监管、智能监管、社会监督等监管范围，建立健全重要线索、重大案件联查联办和追责问责机制，坚决守住基金安全底线。

六、组织实施

各县（市、区）、市直有关部门要强化组织领导，密切协调配合，妥善回应公众关切，统筹推进长期护理保险工作，重大事项及时按程序向市委、市政府请示报告。

民政、卫生健康、残联与医保部门共同负责加强保险体系和服务体系协同联动、探索失能等级评估结果跨部门互认机制等。民政、财政、医保、残联等部门共同做好相关保险与补贴制度的衔接。

医保部门负责全市长期护理保险的政策制定和组织实施，加强对基金筹集、失能等级评估、待遇支付、协议管理等环节的监督管理，做好对基金运行的监测分析，确保基金安全可持续；会同相关部门根据本方案制定配套文件；定期组织相关部门会商，督促各项工作落实。

财政部门负责及时足额安排相关财政补助资金，配合做好基金测算等。

税务部门负责做好长期护理保险保费征收等工作。

民政部门负责加强对养老服务机构的行业管理，统筹配置养老服务资源，配合医保部门规范定点养老服务机构的服务行为；指导养老服务机构及养老护理员参与长期护理服务工作。

卫生健康部门负责对开展医疗护理的定点服务机构的医疗行为进行监管和技术指导；配合医保部门做好失能等级评估、评估人员管理；鼓励基层医疗卫生机构提供长期护理服务、探索发挥家庭医生在失能等级评估中的作用等。

人社部门负责落实职业技能培训政策，指导相关符合条件人员开展长期护理技能等级认定工作;组织失能等级评估人员培训、考核；配合做好长期护理保险与工伤保险（含补充工伤保险）衔接、退休人员养老金数据共享及保费代扣代缴等工作。

农业农村部门负责做好防止返贫致贫对象认定和帮扶工作，积极支持和引导农村转移劳动力等参与长期照护师培训。

商务部门负责积极支持引导家政服务人员等参与长期照护师培训。

教体部门负责指导有关高校、职业院校等学校对照长期照护师国家职业标准要求，深化相关专业人才培养模式改革，畅通就业渠道。

残联部门负责配合医保部门做好丧失劳动能力残疾人身份认定的数据共享、协同做好残疾人参保相关工作。

市直大中专院校负责做好长期护理保险相关专业的开设工

作，组织在校学生参加长期照护师职业技能培训与考试，培养相关专业技能人才。

本实施方案自2026年10月1日起施行，施行期间国家、省有新政策规定的，按新的政策规定执行。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，吉安军分区，市法院，市检察院，各人民团体。

吉安市人民政府办公室　　2026年6月30日印发